



المريض الأسير

التكامل الرأسى والتركّز الاحتكاري
في منظومة الرعاية الصحية الأمريكية

The Captive Patient

Vertical Integration & Market Concentration
in the U.S. Healthcare System

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

Arabic & English 2026 عربي - إنجليزي

المريض الأسير

التكامل الرأسي والتركز الاحتكاري في منظومة الرعاية الصحية
الأمريكية

The Captive Patient

Vertical Integration and Market Concentration in the U.S.
Healthcare System

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

الطبعة الأولى — 2026

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المريض الأسير

التكامل الرأسي والتركز الاحتكاري في منظومة الرعاية الصحية
الأمريكية

إلى كلّ مريضٍ وقف عاجزاً أمام فاتورةٍ لا يفهمها، ودواءٍ لا يقدر على

ثمنه،

في منظومةٍ تعدُّ بالشفاء وتُتاجر بالألم،
وإلى مَنْ آمنوا أنّ الصحة حقٌّ لا سلعة.



وإلى روح والدي رحمه الله، وإلى أمي حفظها الله،
وإلى زوجتي وأولادي، وإخواني وأخواتي.

المحتويات

6	مقدمة
8	الفصل الأول: حين تصبح الصيدلية إمبراطورية
11	الفصل الثاني: الاستراتيجية الأسيرة — رحلة « كيت »
13	الفصل الثالث: مديرو منافع الصيدلة — الوسطاء الخفيون
15	الفصل الرابع: هوامش باهظة — ماذا كشفت لجنة التجارة الفيدرالية
17	الفصل الخامس: التعامل الذاتي ونسبة الخسارة الطبية
19	الفصل السادس: موت المنافسة — درس من الكساد الكبير
21	الفصل السابع: الحجّة المضادة — هل يخفض التكامل الكلفة فعلاً؟
23	الفصل الثامن: ماذا يمكن فعله؟ التفكيك والشفافية والإصلاح
25	خاتمة
27	المراجع العلمية
29	English Translation
56	نبذة عن المؤلف — About the Author
57	مؤلفات المؤلف

مقدمة

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

المطففين: 1-3

تخيل أن شركة واحدة تباعك تأمينك الصحي، وتملك العيادة التي تزورها، وتوظف الطبيب الذي يكتب لك الوصفة، وتدير الصيدلية التي تصرف الدواء، بل وتملك أيضاً الوسيط الذي يحدد سعر ذلك الدواء، وربما المصنع الذي أنتجه. في كل خطوة من رحلتك العلاجية تدفع المال، وفي كل خطوة يعود ذلك المال إلى الجيب نفسه. هذا ليس سيناريو خيالياً؛ إنه الوصف الدقيق لما أصبحت عليه بعض أكبر شركات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة اليوم.

في جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي، عرضت النائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز على الرئيس التنفيذي لشركة «سي في إس هيلث» (CVS Health) ما وصفته بـ«الاستراتيجية الأسيرة» (Captive Strategy): مريضة افتراضية تحمل بوليصة تأمين من شركة «أيتنا»، تراجع طبيباً في عيادات «أوك ستريت هيلث»، فيكتب لها وصفة تصرفها في صيدلية «سي في إس»، بسعر يحدده مدير منافع الصيدلة «سي في إس كيرمارك». المفارقة أن هذه الكيانات الأربعة ليست شركات متنافسة، بل أذرع لشركة أم واحدة.

هذا الكتاب لا يطرح نظرية مؤامرة، ولا يكتفي بالشعارات. إنه محاولة لتفكيك بنية اقتصادية حقيقية وموثقة: ظاهرة «التكامل الرأسى» (Vertical Integration) في قطاع الرعاية الصحية، حيث تبتلع الشركة الواحدة كل حلقة في سلسلة العلاج. سنعتمد على وثائق رسمية، أبرزها تقارير لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، وعلى محاضر جلسات الكونغرس، وعلى بيانات الشركات نفسها في مكالماتها مع المستثمرين.

وبحكم عملي باحثاً في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة ميشيغان، أتعامل يومياً مع البيانات الطبية والجينومية، وأرى كيف تتحول المعلومة الصحية إلى أصل تجاري ثمين. إنَّ مَنْ يملك بياناتك الصحية، ويملك في الوقت ذاته التأمين والعيادة والصيدلية، يملك قدرة غير مسبوقة على توجيه قراراتك العلاجية بما يخدم ربحه قبل صحتك. هذه هي الإشكالية الجوهرية التي يدور حولها الكتاب.

لن أكون منحازاً إلى طرفٍ دون آخر. سأعرض الحجة كاملةً: لماذا يرى المنتقدون أنَّ هذا النموذج يُفسد المنافسة ويرفع الأسعار؟ ولماذا تردّ الشركات بأنّ التكامل يخفض الكلفة ويُحسِّن تنسيق الرعاية؟ ثم نسأل السؤال الأهم: ما الذي يمكن فعله؟ وهل التفكيك هو الحل، كما حدث مع المصارف بعد الكساد الكبير؟ هدفي أن يخرج القارئ بفهمٍ واضحٍ يميّنه من الحكم بنفسه، لا أن أُملّي عليه نتيجةً جاهزة.

الفصل الأول: حين تصبح الصيدلية إمبراطورية

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

البقرة: 188

لفهم ما يجري، علينا أولاً أن نفهم معنى «التكامل الرأسي». في الاقتصاد، تنقسم استراتيجيات نمو الشركات إلى نوعين: التكامل الأفقي، حين تشتري الشركة منافسها في المستوى نفسه (صيدلية تشتري سلسلة صيدليات أخرى)؛ والتكامل الرأسي، حين تشتري الشركة حلقاتٍ مختلفة في سلسلة الإنتاج والتوزيع (الصيدلية تشتري شركة التأمين، ثم العيادة، ثم المصنع). الأول يوسّع الحصة السوقية في خطوة واحدة، أما الثاني فيمنح الشركة سيطرةً على الرحلة كلها من البداية إلى النهاية.

قصة «سي في إس» نموذجٌ مكتمل لهذا التحول. بدأت عام 1963 متجراً صغيراً لمستحضرات التجميل والعناية باسم «متاجر القيمة للمستهلك» (Consumer Value Stores)، ومنه جاء الاختصار CVS. ظلّت لعقودٍ سلسلة صيدلياتٍ للبيع بالتجزئة، حتى بدأت رحلة الابتلاع الرأسي. ففي عام 2007 اندمجت مع شركة «كيرمارك» (Caremark)، وهي «مدير منافع صيدلة» (PBM) ضخمة، لتدخل عالم الوساطة الدوائية. ثم جاءت الضربة الكبرى عام 2018 بالاستحواذ على شركة التأمين العملاقة «أيتنا» (Aetna) بنحو سبعين مليار دولار.

لم تتوقف الشبهة عند هذا الحد. في عام 2023 استحوذت الشركة على «أوك ستريت هيلث» (Oak Street Health)، وهي شبكة عياداتٍ للرعاية الأولية تركز على كبار السن المشمولين ببرنامج «ميديكير»، بنحو 10.6 مليار دولار، وعلى «سيغنفاي هيلث» (Signify Health) للرعاية المنزلية بنحو ثمانية مليارات. وفي السنوات الأخيرة أطلقت «كوردافيس» (Cordavis) لإنتاج وتسويق الأدوية الحيوية المماثلة (Biosimilars). وهكذا اكتملت الحلقة: تأمين، ووساطة دوائية، وعيادات، وصيديات، ومصنع.

والنتيجة رقمٌ يصعب تصوّره: شركةٌ تتجاوز إيراداتها السنوية المتوقعة لعام 2025 نحو 390 مليار دولار، وتقع فروعها على بُعد أقل من خمسة أميال من نحو 85% من سكان الولايات المتحدة. لم تعد «سي في إس» صيدلية؛ صارت منظومةً صحية مغلقة، أو ما يسميه المحللون «نظاماً بيئياً دفاعياً» (Defensive Ecosystem) يحبس المريض داخله.

والمسألة لا تخصّ «سي في إس» وحدها. فالسوق الأمريكية تهيمن عليها ثلاث إمبراطوريات متكاملة رأسياً: «سي في إس هيلث» التي تملك «أيتنا» و«كيرمارك»؛ و«يونيتد هيلث جروب» (UnitedHealth) التي تملك «أوبتم آر إكس» (OptumRx) وشبكاتٍ هائلة من الأطباء؛ و«سيغنا» (Cigna) التي تملك «إكسبريس سكريبتس» (Express Scripts). هذه الكيانات الثلاثة تدير معاً الجزء الأعظم من تدفق الأدوية في البلاد، وهو ما يجعل الحديث عن «منافسة» في هذا القطاع حديثاً يحتاج إلى مراجعة.

في الفصول التالية سنتتبّع كيف يعمل هذا التكامل خطوةً بخطوة، وكيف يتحوّل من وعدٍ بكفاءةٍ أعلى إلى أداةٍ لاحتكار القرار العلاجي. لكن المبدأ القرآني الذي صدرنا به هذا

الفصل يظل البوصلة: النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ليس شعاراً أخلاقياً فحسب، بل قاعدةً اقتصادية تحمي ضعيف الحال من قوّة تملك كلّ أوراق اللعبة.

الفصل الثاني: الاستراتيجية الأسيرة — رحلة « كيت »

﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

الشعراء: 80

في إحدى مكالمات «سي في إس» مع المستثمرين، عرضت الشركة بنفسها مثالاً توضيحياً لمريضة سُمّتها «كيت». وقد التقطت النائبة أوكاسيو-كورتيز هذا المثال وأعادت عرضه في الكونغرس بوصفه تجسيداً حياً لما أسمته «الاستراتيجية الأسيرة». تستحق رحلة «كيت» أن تأملها خطوة خطوة، لأنها تكشف البنية الخفية للنظام.

تبدأ «كيت» رحلتها بوثيقة تأمين صحي من شركة «أيتنا». هذه الوثيقة تحدّد أيّ الأطباء «داخل الشبكة»، وأيّ الأدوية «مغطاة»، وكَم ستدفع من جيبها. لكن «أيتنا» مملوكة لـ«سي في إس». ثم تذهب «كيت» إلى طبيبٍ في عيادة «أوك ستريت هيلث» — وهي أيضاً مملوكة لـ«سي في إس». يكتب الطبيب وصفةً دوائيةً، فتتوجّه «كيت» لصرفها في صيدلية «سي في إس». وحين يُحدّد سعر الدواء، يكون مدير منافع الصيدلة «سي في إس كيرمارك» — المملوك للشركة نفسها — هو من يضع ذلك السعر.

لاحظ ما حدث: في كل محطة من محطات الرحلة الأربع، دفعت «كيت» مالاً، وفي كل محطة كان المستفيد هو الكيان نفسه. شركة التأمين تجمع الأقساط، والعيادة تتقاضى أجر الزيارة، والصيدلية تربح من البيع، والوسيط يربح من تحديد السعر والرسوم. ولأنّ الجهات الأربع تنتمي لشركة أم واحدة، فإنّ كل دولار يخرج من جيب «كيت» يعود

في النهاية إلى الميزانية الموحدة نفسها. هذه هي عبقرية النموذج من منظور الربح، وخطورته من منظور المريض.

السؤال الجوهرى هنا: لمصلحة مَنْ تُتخذ القرارات؟ حين يكون الطبيب موظفًا لدى الشركة التي تملك التأمين والصيدلية، فأَيُّ دواءٍ سيميل إلى وصفه؟ وحين يكون الوسيط الذي يقرّر تغطية الدواء مملوكًا للجهة نفسها التي تبيعه، فهل سيختار الأرخص للمريض أم الأعلى ربحًا للشركة؟ لا نَتهِم هنا أفرادًا بسوء النية، بل نشير إلى أنّ بنية المصالح ذاتها تخلق ضغطًا منهجيًّا يدفع باتجاه ربح الشركة.

تكمّن خطورة «الاستراتيجية الأسيرة» في أنها تلغي حرية الاختيار من حيث المظهر مع الإبقاء عليها شكليًّا. تشعر «كيت» أنها تختار طبيبها وصيدليتها، لكن خياراتها كلها مرسومةٌ داخل دائرةٍ واحدة. وكلما اتّسعت الإمبراطورية، ضاقت المساحة التي يمكن للمريض أن يتنفس فيها خارج سيطرتها. وهنا يصبح الاسم دقيقًا: مريضٌ أسير.

الآية التي صدرنا بها الفصل — على لسان إبراهيم عليه السلام — تنسب الشفاء إلى الله وحده. وفي ذلك تذكيرٌ بأنّ الطب وسيلةٌ لا غاية، وأنّ تحويل الشفاء إلى مجرد حلقةٍ في سلسلة ربح مغلقة يُفرغه من معناه الإنساني العميق. المريض ليس وحدةً في جدول أرباح، بل إنسانٌ يستحق أن يُتخذ القرار من أجله، لا من أجل العائد على السهم.

الفصل الثالث: مديرو منافع الصيدلة — الوسطاء الخفيون

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾

الإسراء: 35

في قلب هذه المنظومة يقف لاعبٌ لا يعرفه كثيرٌ من المرضى، رغم أنه يحدّد أسعار أدويتهم: «مدير منافع الصيدلة» (Pharmacy Benefit Manager) أو اختصاراً PBM. نشأ هذا الكيان في الأصل ليكون وسيطاً يخدم أصحاب العمل وخطط التأمين، يتفاوض مع شركات الأدوية للحصول على أسعارٍ أفضل، ويدير قوائم الأدوية المغطاة (Formularies). لكنّ ما بدأ أداةً لخفض الكلفة تحوّل، في نظر منتقديه، إلى آلةٍ لتضخيمها.

يعمل الوسيط في منطقةٍ رمادية بين المصنّع وشركة التأمين والصيدلية. يتفاوض على «حسومات» (Rebates) من شركات الأدوية مقابل إدراج أدويتها في قوائم التغطية، لكنّ جزءاً من هذه الحسومات قد لا يصل إلى المريض. كما يمارس ما يُعرف بـ«تسعير الفارق» (Spread Pricing): يطالب خطة التأمين بمبلغ أكبر مما يدفعه فعلياً للصيدلية، ويحتفظ بالفارق. وقد قدّرت لجنة التجارة الفيدرالية أنّ كبار الوسطاء جنوا نحو 1.4 مليار دولار من تسعير الفارق على أدوية متخصصة في فترةٍ محدودة.

تتركّز القوة هنا بشكلٍ مذهل. فالوسطاء الثلاثة الكبار — «سي في إس كيرمارك»، و«إكسبريس سكريبس»، و«أوبتم آر إكس» — يديرون معاً الجزء الأعظم من

الوصفات الطبية في الولايات المتحدة؛ إذ تشير التقديرات إلى أنّ «كيرمارك» وحده يعالج نحو 30% من جميع الوصفات سنوياً. وحين يتحكّم ثلاثة لاعبين في هذا الكمّ الهائل، فإنّ قراراتهم تصبح بحكم الأمر الواقع قانوناً للسوق.

ما يزيد الإشكال أنّ هؤلاء الوسطاء الثلاثة مملوكون لشركاتٍ تملك أيضاً صيديّاتها الخاصة وشركات تأمينها. أي أنّ الوسيط الذي يُفترض أن يكون محايداً بين المصنّع والمريض، صار طرفاً له مصلحةٌ مباشرة في توجيه الوصفة إلى صيدلية الشركة الأم. وهنا يتحوّل دوره من «حكّم» في السوق إلى «لاعبٍ» فيها، وهو تضاربٌ في المصالح يصعب تبريره.

الشفافية تكاد تكون معدومة. فآليات تحديد السعر الحقيقي، وحجم الحسومات، ووجهة الفروقات السعرية، كلها محجوبةٌ خلف عقودٍ سرّية وتعقيدٍ متعمّد. هذا «التعتيم» ليس عيباً عَرَضِيّاً، بل هو في كثيرٍ من الأحيان جزءٌ من النموذج: فكما صُعِبَ على المريض وصاحب العمل تتبّع المال، اتّسعت مساحة الربح غير المرئي.

إنّ الآية الكريمة تأمر بإيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم. وهذا المبدأ — العدل في القياس والشفافية في المعاملة — هو بالضبط ما تفتقر إليه منظومة الوساطة الدوائية حين تتحوّل من خدمة للمريض إلى صندوقٍ أسودٍ للربح. الإصلاح يبدأ من إعادة الميزان إلى استقامته: شفافيةٌ في الأسعار، وفصلٌ بين مَنْ يحدّد السعر ومَنْ يبيع الدواء.

الفصل الرابع: هوامش باهظة — ماذا كشفت لجنة التجارة الفيدرالية

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾

المطففين: 1

في يناير 2025 أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تقريرها المرحلي الثاني عن وسطاء الأدوية، وكان وثيقةً مدوّية. فقد فحصت اللجنة 51 دواءً متخصصاً من الأدوية الجنيسة (Specialty Generics) صُرفت بين عامي 2017 و2022، وقارنت أسعارها بالكلفة الوطنية المتوسطة لاقتناء الدواء (NADAC)، أي ما تدفعه الصيدلية فعلياً للحصول عليه.

كانت النتائج صادمة. فقد رفع الوسطاء الثلاثة الكبار أسعار كثيرٍ من هذه الأدوية في صيدلياتهم التابعة بنسبٍ تتراوح من مئاتٍ إلى آلافِ المئويات. بعض أدوية السرطان جرى تضخيم سعرها بأكثر من 1000%، فيما تراوحت هوامش أدوية فيروس نقص المناعة (HIV) وأدوية زراعة الأعضاء بين 100% و1000%. وفي مثالٍ موثقٍ، شهد دواء «كايسيتابين» — وهو علاجٌ لسرطان الثدي والقولون — هامشاً بلغ نحو 3289% في عام 2021.

والحصيلة المالية لهذه الهوامش هائلة: جنى الوسطاء الثلاثة وصيدلياتهم التابعة أكثر من 7.3 مليار دولار من الإيرادات الزائدة عن كلفة الاقتناء في الفترة من 2017 إلى

2022. وقد شكّلت أدوية السرطان وحدها نحو نصف هذا المبلغ (قراءة 3.3 مليار دولار)، تلتها أدوية التصلّب المتعدّد بنحو الربع. تخيل: مليارات الدولارات اقتُطعت فوق الكلفة الحقيقية لأدويةٍ يحتاجها مرضى السرطان للبقاء على قيد الحياة.

لكنّ التقرير كشف ما هو أخطر من الأرقام: نمطٌ متعمّد من «توجيه المرضى» (Patient Steering). فبينما كانت الصيدليات التابعة للوسطاء تصرف نحو 44% من وصفات الأدوية المتخصّصة عموماً، فإنها استحوذت على نحو 72% من الوصفات الأعلى ربحاً (تلك التي تجاوز هامشها 1000 دولار للوصفة). أي أنّ النظام يوجّه الوصفات المربحة بعنايةٍ نحو صيدليات الشركة الأم، تاركاً الأقل ربحاً لغيرها.

ولأنّ هؤلاء الوسطاء مملوكون لشركات متكاملة رأسياً، فإنّ هذه الأرباح لا تتبخر، بل تنتقل إلى الميزانية الموحّدة للشركة الأم. وقد قدّرت اللجنة أنّ الدخل التشغيلي من هذه الأدوية المتخصّصة بلغ في عام 2021 نحو 12% من إجمالي الدخل التشغيلي لقطاعات الأعمال المرتبطة بالوساطة والصيدلة لدى هذه الشركات العملاقة. إنها ليست هامشاً جانبياً، بل ركيزةٌ من ركائز الربح.

حدّرت اللجنة من أنّ هذه الممارسات قد تستدعي «تنظيماً عاجلاً». وهنا تكتسب الآية الكريمة ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ حضوراً مدوّياً: فالتطفيف ليس مقصوداً على بائعٍ يغشّ في كيلٍ صغير، بل يمتدّ إلى منظومةٍ تضخّم أسعار دواء السرطان آلاف المئويات على مرضى لا حول لهم ولا قوة. والوعيد في الآية يخصّ مَنْ يستوفي حقّه كاملاً، ويخس الناس حقوقهم.

الفصل الخامس: التعامل الذاتي ونسبة الخسارة الطبية

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

النحل: 90

ثمة آلية تنظيمية يُفترض أن تحمي المريض، لكنها قد تنقلب إلى ثغرة تُستغل. يفرض «قانون الرعاية الميسرة» (ACA) على شركات التأمين أن تتفق نسبةً دنيا من أقساط التأمين على الرعاية الطبية الفعلية، وتُعرف هذه النسبة بـ«نسبة الخسارة الطبية» (Medical Loss Ratio - MLR). الهدف نبيل: منع شركات التأمين من احتجاز أموال الأقساط كأرباح بدل إنفاقها على علاج المرضى.

لكن ماذا يحدث حين تملك شركة التأمين نفسها مقدّم الرعاية؟ هنا تظهر إشكالية «التعامل الذاتي» (Self-Dealing). فحين تدفع «أيتنا» (التأمين) ثمن الرعاية لعيادة «أوك ستريت» (مقدّم الرعاية المملوك للشركة نفسها)، فإنها في الحقيقة تدفع لنفسها. ومن ثمّ تُحتسب هذه المبالغ ضمن «الإنفاق على الرعاية» المطلوب نظامياً، بينما تبقى في النهاية داخل الشركة الأم. بهذه الطريقة يمكن استيفاء شرط النسبة شكلياً، مع الاحتفاظ بحصة أكبر من كلفة الرعاية فعلياً.

هذه ليست بالضرورة مخالفةً صريحةً للقانون، وهذا بالذات هو جوهر المشكلة. فالتكامل الرأسي يتيح إعادة تعريف ما يُحسب «ربحاً» وما يُحسب «كلفة رعاية»، لأنّ الحدود بين

الكيانات التي يفترض أن تكون مستقلة قد ذابت. حين يكون البائع والمشتري والوسيط جهةً واحدة، تفقد الأرقام التي تعتمد عليها الجهات التنظيمية معناها الحقيقي.

ولهذا يحاجّ المنتقدون بأنّ التكامل الرأسي لا يلتفّ على روح قانون الرعاية الميسرة فحسب، بل يفرّغ آليات الرقابة من مضمونها. فكيف يمكن للمنظم أن يتحقّق من عدالة التسعير في معاملة يكون طرفاها كيانين تابعين لهالك نفسه؟ تصبح المراجعة المستقلة شبه مستحيلة، ويصبح الرقم المعلن عرضةً للتشكيل بحسب مصلحة الشركة.

ينبغي الإنصاف هنا: تردّ الشركات بأنّ امتلاك مقدّم الرعاية يتيح تنسيقاً أفضل، ويقلّل من الإجراءات المكرّرة، ويخفض دخول المستشفيات المكلفة عبر الوقاية المبكرة. وهذه حجج تستحق النظر، وسنفرد لها الفصل السابع. لكنّ وجود منفعة محتملة لا يلغي وجود تضاربٍ بنيوي في المصالح يحتاج إلى رقابة صارمة وشفافية كاملة.

العدل والإحسان اللذان تأمر بهما الآية ليسا قيمتين متعارضتين مع الكفاءة الاقتصادية، بل شرطان لاستدامتها. فالسوق الذي يفقد عدله يفقد ثقة الناس فيه، ومنظومةٌ صحية تُبنى على غياب الشفافية تتآكل من الداخل مهما بدت أرباحها لامعة. الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة الفصل بين الأدوار، بحيث يُحاسب كلّ طرفٍ على وظيفته لا على قدرته في إخفاء أرباحه.

الفصل السادس: موت المنافسة — درس من الكساد الكبير

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْغَىٰ ۖ أَن رَّاهُ اسْتَعْجَىٰ﴾

العلق: 6-7

تقوم فكرة السوق الحرة على اقتراضٍ بسيط: أنَّ الشركات تتنافس على رضا العميل، فتحسّن الخدمة وتخفض الأسعار. لكنّ هذا الاقتراض ينهار حين تختفي المنافسة. وهذا بالضبط ما يحدث، في رأي المنتقدين، حين تبتلع شركة واحدة كلّ حلقات السلسلة: لم تتنافس على المريض إذا كنتَ تملك تأمينه وعيادته وصيديليته أصلاً؟

حين يصبح المريض «أسيراً» داخل منظومة مغلقة، تفقد الشركة الحافز لتحسين الخدمة أو خفض السعر، لأنّ المريض لا يملك بديلاً حقيقياً. فبدلاً من أن تتنافس الكيانات على جذبه، تتعاون ضمناً على استبقائه واستخلاص أقصى قيمة منه. هذا هو المعنى العميق لعبارة أنّ هذا النموذج «يدمرّ قدرة الناس على الوصول إلى الرعاية»: ليس بمنعهم منها مباشرة، بل بإلغاء البدائل التي تُبقي الأسعار معقولة.

ولهذا طرح بعض المشرّعين تشبيهاً تاريخياً لافتاً: حال القطاع المصرفي قبل الكساد الكبير عام 1929. فقد كانت المصارف آنذاك تجمع بين أنشطة متضاربة — الإقراض، والاستثمار المضارب، وإدارة ودائع الناس — تحت سقفٍ واحد، فتولّد تضاربُ المصالح مخاطرَ هائلة أسهمت في الانهيار. وكان الردّ التشريعي هو «قانون غلاس-

ستيغال» (Glass-Steagall) عام 1933، الذي فصل بين المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية، حمايةً لأموال المودعين.

القياس واضح: كما فصل بين وظائف المصارف لحماية المودع، يُقترح الفصل بين وظائف الرعاية الصحية لحماية المريض. أن يُمنع المؤمن من امتلاك مقدّم الرعاية والوسيط الدوائي في آنٍ واحد، تمامًا كما مُنع المصرف التجاري من المضاربة بأموال المودعين. الفكرة ليست معاداة الشركات، بل إعادة بناء الحواجز التي تحفظ التوازن وتُبقي المنافسة حية.

وهنا تحضر الآية الكريمة بدلالة عميقة: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾. فالطغيان — في بعده الاقتصادي — ثمرةٌ طبيعية للاستغناء عن الحاجة إلى الآخر. والشركة التي تملك كلَّ شيء تستغني عن الحاجة إلى إرضاء العميل، فتطغى على السوق وعلى المريض. الحلّ ليس في تجريم النجاح، بل في منع تركّز القوة إلى حدٍّ يُلغي الحاجة إلى العدل.

إنّ موت المنافسة لا يُعلن في بيانٍ صحفي، بل يتسلّل بهدوء: خياراتٌ تضيق، وأسعارٌ ترتفع دون تفسير، وصيدياتٌ مستقلةٌ تغلق أبوابها لأنها لا تستطيع منافسة عملاقٍ يحدّد بنفسه سعر الجملة الذي تشتري به. وحين تختفي هذه الصيدليات الصغيرة، يفقد المريض آخر بدائله، ويكتمل القفص.

الفصل السابع: الحجة المضادة — هل يخفض التكامل الكلفة فعلاً؟

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوٓا۟ ۖ اِعْدِلُوٓا۟ ۚ﴾^ج

المائدة: 8

الإنصاف يقتضي أن نعرض حجة الطرف الآخر بأقوى صورها، لا بأضعفها. فالشركات الكبرى لا ترى في التكامل الرأسي مؤامرةً على المريض، بل حلاً لمشكلة حقيقية: تشتت النظام الصحي الأمريكي وتفككه. ولهم في ذلك حججٌ جديرة بالتأمل.

الحجة الأولى هي «تنسيق الرعاية» (Care Coordination). ففي نظامٍ مفكك، قد لا يعرف الطبيب ما وصفه طبيبٌ آخر، وقد تتعارض الأدوية، وتتكرر الفحوص المكلفة بلا داعٍ. أما حين تملك جهةً واحدةً بيانات التأمين والعيادة والصيدلية، فبإمكانها — نظرياً — أن تبني صورةً متكاملة عن المريض، فتكتشف التعارضات الدوائية مبكراً، وتتدخل قبل أن تتفاقم الحالة. وقد أطلقت بعض الشركات منصّات تعتمد الذكاء الاصطناعي لرصد المرضى المعرضين للأمراض المزمنة وتوجيههم للرعاية الوقائية قبل دخول المستشفى.

الحجة الثانية هي «خفض الكلفة عبر الوقاية». فدخل المستشفى مكلفٌ جداً، وكلّ نوبةٍ قلبية أو مضاعفةٍ لمرض السكري يمكن تفاديها توفير آلاف الدولارات. وتقول الشركات إنّ امتلاك سلسلة الرعاية يتيح لها الاستثمار في الوقاية وتوجيه المرضى نحو الخيارات

الأقل كلفة (كالعيادة بدل غرفة الطوارئ)، وهو ما يخدم المريض والممول معاً. وهذا منطق سليم من حيث المبدأ، فالرعاية المنسقة المبنية على البيانات قد تكون أكفأ فعلاً.

الحجة الثالثة هي «اقتصاديات الحجم» (Economies of Scale). فالشركة الضخمة تستطيع التفاوض على أسعار أفضل، وتوزيع التكاليف الإدارية على قاعدة أوسع، والاستثمار في تقنيات يعجز عنها اللاعب الصغير. ومنه «كوردافيس»، التي تقول «سي في إس» إنها أنشئت لإنتاج أدوية حيوية مماثلة أرخص، تنافس الأدوية الأصلية الباهظة وتخفض الكلفة على المرضى.

لكن هذه الحجج، على وجاهتها، تواجه اختباراً واحداً حاسماً: الأدلة. فالوعد بالكفاءة لا يكفي، المطلوب أن تظهر آثاره في فواتير المرضى فعلاً. وحين تكشف وثائق لجنة التجارة الفيدرالية عن هوامش تبلغ آلاف المثويات، وعن توجيهٍ ممنهج للوصفات المربحة، يصبح من المشروع أن نسأل: أين ذهبت وفورات الكفاءة الموعودة؟ هل انتقلت إلى المريض، أم بقيت في صافي ربح الشركة؟ التكامل قد يخلق كفاءة، لكن غياب المنافسة قد يحول تلك الكفاءة إلى ربح محتجَز لا يصل إلى الناس.

الآية التي صدرنا بها الفصل تأمر بالعدل حتى مع من نخالفهم: ألا يحملنا بغض جهةٍ على ظلمها. فلا ننكر على الشركات حقها في الربح المشروع ولا في الابتكار، ولا نتهمها جزافاً. لكن العدل ذاته يقتضي أن نطالبها بالشفافية، وأن نقيس وعودها بالأدلة لا بالشعارات. الحكم النهائي يجب أن يبنى على البيانات، وهي حتى الآن تميل لصالح المنتقدين أكثر مما تميل لصالح المدافعين.

الفصل الثامن: ماذا يمكن فعله؟ التفكيك والشفافية والإصلاح

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

المائدة: 2

إذا كان التشخيص هو تركّز القوة، فإنّ العلاج يدور حول إعادة توزيعها وإخضاعها للرقابة. وقد طُرحت في النقاش العام عدّة مسارات للإصلاح، تتفاوت في جذريتها، لكنها تشترك في هدفٍ واحد: تحرير المريض من القفص.

المسار الأول هو «التفكيك البنوي» (Structural Separation). وهو المقترح الأكثر جذرية، ومضمونه منع الكيان الواحد من الجمع بين التأمين والوساطة الدوائية وملكية الصيدليات. وهنا يحضر التشبيه بقانون غلاس-ستيغال: كما فُصلت المصارف، يُفصل بين أذرع الرعاية الصحية. التفكيك يعيد خلق المنافسة قسراً، لكنه مسارٌ معقّد قانونياً وسياسياً، ويواجه مقاومةً هائلةً من شركاتٍ بمليارات الدولارات.

المسار الثاني هو «الشفافية الإلزامية». فبدل تفكيك الشركات، يلزَم الوسيط بالكشف عن آليات التسعير الحقيقية: كم تدفع الصيدلية فعلاً؟ كم حجم الحسومات؟ أين يذهب فارق السعر؟ حين يُجبر النظام على العمل في وضخ النهار، يصعب إخفاء الهوامش المبالغ فيها. الشفافية وحدها قد لا تكفي، لكنها شرطٌ لازم لأيّ إصلاحٍ آخر.

المسار الثالث هو «تحويل الحسومات إلى المريض» وتنظيم تسعير الفارق. أي إلزام الوسطاء بتمرير ما يحصلون عليه من حسوماتٍ إلى المريض مباشرةً عند نقطة البيع، بدل احتجازها في مكانٍ ما داخل المنظومة. وكذلك حظر أو تقييد ممارسة «تسعير الفارق» التي تجني منها هذه الشركات مليارات. هذه إصلاحاتٌ جزئيةٌ لكنها عملية وقابلة للتطبيق سريعاً.

المسار الرابع هو «تمكين البدائل». فدعم الصيدليات المستقلة والمجتمعية، ومنع توجيه المرضى قسراً نحو صيدليات الشركة الأم، يعيد بعض التوازن إلى السوق. حين يملك المريض خياراً حقيقياً، يستعيد جزءاً من قوّته التفاوضية المفقودة. والمنافسة، حتى الجزئية، تكبح جماح الاحتكار.

لا يوجد حلٌّ سحري واحد، والأرجح أنّ الإصلاح الناجع سيمزج بين هذه المسارات: شفافيةٌ فورية، وتنظيمٌ صارم لتضارب المصالح، وتفكيكٌ حيث يثبت أنّ الضرر يفوق المنفعة. الآية الكريمة ترسم القاعدة الحاكمة: التعاون على البرّ والتقوى لا على الإثم والعدوان. ومنظومةٌ صحيةٌ عادلة هي تعاونٌ على البرّ بامتياز؛ أما منظومةٌ تراكم الربح على حساب المريض المريض العاجز فهي تعاونٌ على ضدّ ذلك. والمسؤولية هنا جماعية: على المشرّع، والمنظم، والطبيب، والمواطن، أن يطالبوا جميعاً بأن تعود الصحة حقّاً، لا سلعةً في قفصٍ مغلق.

خاتمة

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي
الْأَرْضِ﴾

الرعد: 17

بدأنا هذا الكتاب بصورةٍ مقلقةٍ: مريضةٌ تدور في حلقةٍ مغلقةٍ، كلُّ خطوةٍ فيها تعود بالمال إلى الجيب نفسه. واثبتنا إلى أنَّ هذه الصورة ليست خيالاً، بل بنيةٌ اقتصادية موثقةٌ بوثائق الجهات الرقابية وشهادات الكونغرس وبيانات الشركات. التكامل الرأسي في الرعاية الصحية ظاهرةٌ حقيقية، ونتائجها على أسعار الأدوية وحرية اختيار المريض ملهوسة.

لكنَّ الإنصاف الذي التزمناه يفرض ألا نغلق الباب على وجهٍ واحد. فالتكامل قد يحمل وعوداً حقيقية بالكفاءة وتنسيق الرعاية. المشكلة ليست في الفكرة المجردة، بل في غياب المنافسة والشفافية اللذين يحولان الكفاءة المحتملة إلى احتكارٍ فعلي. حين يملك طرفٌ كلَّ أوراق اللعبة، فإنَّ حسن النية وحده لا يكفي ضماناً؛ المطلوب بنيةٌ تحفظ التوازن.

إنَّ الدرس الأعمق يتجاوز قطاع الصحة. فهو يخصَّ كلَّ سوقٍ يتركز فيه القرار في يدٍ واحدة حتى تختفي الحاجة إلى إرضاء الناس. ومن هنا كانت دعوة بعض المشرعين إلى استلهم درس الكساد الكبير: أن نبني الحواجز قبل الانهيار، لا بعده. حماية المريض ليست عداءً للسوق، بل صونٌ لشرط بقائه عادلاً.

وبصفتي باحثاً أعمل في تقاطع الطب والبيانات، أرى أنَّ المعركة القادمة ستكون حول البيانات الصحية نفسها: مَنْ يملكها، وَمَنْ يستفيد منها. فكما ازدادت قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالمرض وتوجيه العلاج، ازدادت أهمية أن تُوظف هذه القدرة لمصلحة المريض لا لمصلحة العائد على السهم. وهذا تحدٍّ أخلاقي وتنظيمي سيرافقنا سنواتٍ طويلة.

ختاماً، الصحة أمانةٌ قبل أن تكون تجارة، والمريض إنسانٌ قبل أن يكون بنداً في ميزانية. ومهما تعقّدت هياكل الشركات وتشابكت مصالحها، يبقى الميزان القرآني حاكماً: ما ينفع الناس يُمكث، وما هو زبدٌ يذهب جفاءً. نسأل الله أن يرزقنا منظومةً تنفع الناس وتمكث، وأن يهدي القائمين عليها إلى العدل والإحسان.

والله أعلم.

المراجع العلمية

الوثائق الرسمية والتقارير الحكومية

- Federal Trade Commission. "Specialty Generic Drugs: A Growing Profit Center for Vertically Integrated Pharmacy Benefit Managers." Second Interim Staff Report, January 14, 2025
- Federal Trade Commission. "FTC Releases Second Interim Staff Report on Prescription Drug Middlemen." Press Release, January 2025
- U.S. House of Representatives, Office of Rep. Alexandria Ocasio-Cortez. "ICYMI: Ocasio-Cortez Calls Out CVS Health's Corporate Strategy" .Press Release / Committee Hearing Transcript

التكامل الرأسى وهيكى السوق

- Fierce Healthcare. "CVS Closes \$10.6B Acquisition of Oak Street Health .2023
- CVS Health. "Our Path to Accelerating Long-Term Growth" (CVS .Healthspire brand announcement). Company News, 2023
- Union Healthcare Insight. "Key Company Profiles: CVS Health's .Approach to Vertical Integration." 2024

مدير و منافع الصيدلة وتسعير الأدوية

- Fierce Healthcare. "FTC: Big 3 PBMs Generated \$7.3B from Specialty .Generic Drug Markups." 2025

- -Pharmaceutical Commerce. "FTC Report Finds Big Three PBM Mark Ups for Specialty Generics Generated Billions." 2025
- American Journal of Managed Care (AJMC). "FTC Report Highlights Prescription Drug Price Markups by PBMs." 2025–2026

مصادر التفسير القرآني

- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. «تفسير القرآن العظيم». دار طيبة للنشر والتوزيع.
- الطبري، محمد بن جرير. «جامع البيان عن تأويل آي القرآن».
- القرطبي، محمد بن أحمد. «الجامع لأحكام القرآن».
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان».

English Translation

Full English translation of all chapters

Introduction

"Woe to those who give short measure — who, when they take by measure from people, take in full; but when they measure or weigh for others, give less."

Qur'an, Al-Mutaffifin 83:1–3

Imagine that a single corporation sells you your health insurance, owns the clinic you visit, employs the doctor who writes your prescription, runs the pharmacy that fills it, and even owns the middleman who sets the drug's price — perhaps the manufacturer too. At every step you pay, and at every step that money returns to the same pocket. This is not fiction; it is a precise description of what some of the largest healthcare companies in the United States have become.

In a congressional hearing, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez presented the CEO of CVS Health with what she called the "captive strategy": a

hypothetical patient insured by Aetna, treated at an Oak Street Health clinic, filling a prescription at a CVS Pharmacy at a price set by the PBM CVS Caremark. The catch is that these four entities are not competitors — they are arms of a single parent company.

This book offers no conspiracy theory and no slogans. It is an attempt to unpack a real, documented economic structure: vertical integration in healthcare, where one company swallows every link in the chain of care. It relies on official documents — chiefly Federal Trade Commission staff reports — on congressional testimony, and on the companies' own investor communications.

As a researcher in computational biology and bioinformatics at the University of Michigan, I work daily with medical and genomic data, and I see how health information becomes a valuable commercial asset. Whoever owns your health data while also owning the insurance, the clinic, and the pharmacy holds an unprecedented power to steer your treatment toward their profit before your health. That is the core problem this book examines.

I will not take only one side. I present the full argument: why critics see this model as corrupting competition and inflating prices, and why companies respond that integration lowers cost and improves coordination. Then comes the key question — what can be done? Is

breaking up the industry the answer, as happened with the banks after the Great Depression? My aim is to leave the reader able to judge for themselves.

Chapter 1: When a Pharmacy Becomes an Empire

"Do not consume one another's wealth unjustly."

Qur'an, Al-Baqarah 2:188

To understand what is happening, we must first understand vertical integration. Corporate growth comes in two forms: horizontal integration, where a company buys competitors at the same level, and vertical integration, where it buys different links in the chain of production and distribution. The first widens market share; the second grants control over the entire journey from start to finish.

CVS is a complete model of this shift. Founded in 1963 as a small health-and-beauty retailer — Consumer Value Stores, hence CVS — it remained a retail pharmacy chain for decades. Then came the vertical acquisitions: a 2007 merger with the giant PBM Caremark, and the decisive 2018 purchase of the insurer Aetna for roughly \$70 billion.

The appetite did not stop. In 2023 CVS acquired Oak Street Health, a primary-care network focused on Medicare seniors, for about \$10.6

billion, and Signify Health for around \$8 billion. It later launched Cordavis to produce and market biosimilars. The circle was complete: insurance, drug brokerage, clinics, pharmacies, and a manufacturer.

The result is a company with projected 2025 revenue near \$390 billion, with locations within five miles of about 85% of the U.S. population. CVS is no longer a pharmacy; it is a closed healthcare ecosystem — what analysts call a "defensive ecosystem" that holds the patient inside.

Nor is this about CVS alone. Three vertically integrated empires dominate the market: CVS Health (owning Aetna and Caremark); UnitedHealth Group (owning OptumRx and vast physician networks); and Cigna (owning Express Scripts). Together these three manage the bulk of the nation's drug flow, which makes talk of genuine "competition" something that needs review.

The Qur'anic principle that opens this chapter remains the compass: the prohibition on consuming people's wealth unjustly is not merely a moral slogan but an economic rule that protects the weak from a power holding all the cards.

Chapter 2: The Captive Strategy — Kate's Journey

"And when I am ill, it is He who cures me."

Qur'an, Ash-Shu'ara 26:80

On a CVS investor call, the company itself presented an illustrative patient it named "Kate." Rep. Ocasio-Cortez took this very example and re-presented it in Congress as a living embodiment of the "captive strategy." Kate's journey deserves a careful, step-by-step look.

Kate begins with an Aetna insurance plan, which determines which doctors are in-network, which drugs are covered, and how much she pays. But Aetna is owned by CVS. She then sees a doctor at an Oak Street Health clinic — also owned by CVS. The doctor writes a prescription, which Kate fills at a CVS Pharmacy. When the drug's price is set, it is CVS Caremark — owned by the same company — that sets it.

Note what happened: at each of the four stops, Kate paid money, and at each the beneficiary was the same entity. Because all four belong to

one parent, every dollar leaving Kate's pocket ultimately returns to the same consolidated balance sheet. This is the genius of the model from a profit view, and its danger from the patient's.

The core question is: in whose interest are decisions made? When the doctor is employed by the company that owns the insurer and the pharmacy, which drug will they lean toward prescribing? When the middleman deciding coverage is owned by the same entity that sells the drug, will it choose the cheapest for the patient or the most profitable for the company? We accuse no individual of bad faith; we note that the very structure of incentives creates systematic pressure toward corporate profit.

The danger of the captive strategy is that it removes real choice while preserving its appearance. Kate feels she chooses her doctor and pharmacy, yet all her options are drawn inside one circle. The larger the empire, the less room the patient has to breathe outside it. Hence the name: a captive patient.

The verse opening this chapter — spoken by Abraham — attributes healing to God alone, a reminder that medicine is a means, not an end. Turning healing into a mere link in a closed profit chain drains it of its deeper human meaning. The patient is not a row in a profit table but a human being for whom the decision should be made.

Chapter 3: Pharmacy Benefit Managers — The Hidden Middlemen

"Give full measure when you measure, and weigh
with an even balance."

Qur'an, Al-Isra 17:35

At the heart of this system stands a player most patients do not know, though it sets their drug prices: the Pharmacy Benefit Manager (PBM). Originally created to serve employers and insurance plans — negotiating with drug makers for better prices and managing formularies — what began as a cost-cutting tool became, in critics' eyes, a cost-inflating machine.

The PBM operates in a gray zone between manufacturer, insurer, and pharmacy. It negotiates rebates from drug makers in exchange for placing their drugs on coverage lists, but part of these rebates may never reach the patient. It also practices "spread pricing": billing the insurance plan more than it actually pays the pharmacy and keeping the difference. The FTC estimated that the major PBMs earned about

\$1.4 billion from spread pricing on specialty drugs over a limited period.

Power is astonishingly concentrated. The three large PBMs — CVS Caremark, Express Scripts, and OptumRx — together manage the bulk of U.S. prescriptions; Caremark alone is estimated to process about 30% of all prescriptions annually. When three players control such volume, their decisions become, in effect, the law of the market.

Worse, these three PBMs are owned by companies that also own their own pharmacies and insurers. The middleman meant to be neutral between maker and patient has become a party with a direct interest in steering the prescription to the parent company's pharmacy. Its role shifts from referee to player — a conflict of interest hard to justify.

Transparency is nearly absent. The real price-setting mechanics, the size of rebates, and the destination of price spreads are hidden behind secret contracts and deliberate complexity. This opacity is often not an accidental flaw but part of the model: the harder it is to follow the money, the wider the space for invisible profit.

The verse commands giving full measure and weighing justly. That principle — fairness in measurement and transparency in dealing — is exactly what drug brokerage lacks when it turns from patient service into a black box for profit. Reform begins by restoring the balance:

price transparency, and separating whoever sets the price from whoever sells the drug.

Chapter 4: Steep Markups — What the FTC Uncovered

"Woe to those who give short measure."

Qur'an, Al-Mutaffifin 83:1

In January 2025 the FTC issued its second interim staff report on drug middlemen — a resounding document. It examined 51 specialty generic drugs dispensed between 2017 and 2022, comparing prices to the National Average Drug Acquisition Cost (NADAC), what a pharmacy actually pays to obtain a drug.

The findings were shocking. The Big 3 PBMs marked up many of these drugs at their affiliated pharmacies by hundreds to thousands of percent. Some cancer drugs were marked up more than 1,000%, while HIV and transplant drugs ranged between 100% and 1,000%. In one documented case, capecitabine — a treatment for breast and colorectal cancer — saw a markup of about 3,289% in 2021.

The financial total is staggering: the three PBMs and their affiliated pharmacies reaped more than \$7.3 billion in revenue above

acquisition cost from 2017 to 2022. Cancer drugs alone accounted for roughly half (about \$3.3 billion), followed by multiple sclerosis drugs at about a quarter — billions extracted above true cost on drugs that cancer patients need to survive.

But the report revealed something graver than the numbers: a deliberate pattern of patient steering. While affiliated pharmacies filled about 44% of specialty prescriptions overall, they captured about 72% of the most profitable prescriptions (those marked up over \$1,000 each). The system carefully routes lucrative prescriptions to the parent company's pharmacies.

Because these PBMs are owned by vertically integrated companies, the profits do not vanish — they flow to the parent's consolidated balance sheet. The FTC estimated that in 2021 operating income from these specialty drugs reached about 12% of the total operating income of the PBM-and-pharmacy business segments. This is not a side margin but a pillar of profit.

The FTC warned that such practices may require "urgent" regulation. Here the verse — "Woe to those who give short measure" — resonates powerfully: short-changing is not limited to a vendor cheating on a small scale, but extends to a system inflating cancer-drug prices by thousands of percent on powerless patients.

Chapter 5: Self-Dealing and the Medical Loss Ratio

"Indeed, God commands justice and good conduct."

Qur'an, An-Nahl 16:90

There is a regulatory mechanism meant to protect patients that can turn into an exploitable loophole. The Affordable Care Act requires insurers to spend a minimum share of premiums on actual medical care — the Medical Loss Ratio (MLR). The goal is noble: to stop insurers from hoarding premium money as profit instead of spending it on patient care.

But what happens when the insurer owns the care provider? Here arises the problem of self-dealing. When Aetna (the insurer) pays for care at an Oak Street clinic (a provider owned by the same company), it is in effect paying itself. These amounts count as the required "spending on care," yet ultimately remain within the parent company. The ratio requirement is formally met while a larger share of care cost is effectively retained.

This is not necessarily a clear legal violation — and that is precisely the problem. Vertical integration allows redefining what counts as "profit" and what counts as "cost of care," because the boundaries between supposedly independent entities have dissolved. When seller, buyer, and middleman are one, the numbers regulators rely on lose their real meaning.

Critics therefore argue that vertical integration not only circumvents the spirit of the ACA but hollows out oversight itself. How can a regulator verify fair pricing in a transaction between two affiliates of the same owner? Independent review becomes nearly impossible, and the reported figure becomes shapeable to the company's interest.

In fairness: companies respond that owning the provider enables better coordination, reduces duplicate procedures, and cuts costly hospital admissions through early prevention. These arguments deserve consideration — Chapter 7 is devoted to them. But a potential benefit does not erase a structural conflict of interest that demands strict oversight and full transparency.

The justice and good conduct the verse commands are not at odds with economic efficiency; they are conditions for its sustainability. A market that loses its fairness loses people's trust, and a health system built on opacity erodes from within however bright its profits appear.

Real reform begins by re-separating roles so each party is held to its function, not to its skill at hiding profit.

Chapter 6: The Death of Competition — A Lesson from the Great Depression

"Nay, but man transgresses, because he sees himself
self-sufficient."

Qur'an, Al-'Alaq 96:6–7

The free market rests on a simple assumption: companies compete for customer satisfaction, so service improves and prices fall. But that assumption collapses when competition disappears — which, critics argue, is what happens when one company swallows every link. Why compete for a patient if you already own their insurance, clinic, and pharmacy?

When the patient becomes captive inside a closed system, the company loses the incentive to improve service or cut prices, because the patient has no real alternative. Instead of competing to attract them, the entities implicitly cooperate to retain them and extract maximum value. This is the deeper meaning of saying the model

"destroys people's ability to access care": not by barring them directly, but by erasing the alternatives that keep prices reasonable.

Hence some legislators have drawn a striking historical analogy: banking before the Great Depression of 1929. Banks then combined conflicting activities — lending, speculative investment, and managing deposits — under one roof, breeding conflicts of interest that helped trigger collapse. The legislative response was the 1933 Glass-Steagall Act, which separated commercial from investment banking to protect depositors.

The analogy is clear: just as bank functions were separated to protect the depositor, separating healthcare functions is proposed to protect the patient — barring an insurer from simultaneously owning the provider and the drug middleman, just as a commercial bank was barred from speculating with deposits. The idea is not hostility to companies but rebuilding the barriers that keep competition alive.

The verse carries deep meaning here: "man transgresses because he sees himself self-sufficient." Transgression, in its economic dimension, is a natural fruit of no longer needing others. A company that owns everything no longer needs to please the customer, so it overreaches the market and the patient. The solution is not to criminalize success

but to prevent power from concentrating to the point that it eliminates the need for fairness.

The death of competition is not announced in a press release; it creeps in quietly: narrowing choices, unexplained price rises, independent pharmacies closing because they cannot compete with a giant that sets the very wholesale price they buy at. When these small pharmacies vanish, the patient loses their last alternative, and the cage is complete.

Chapter 7: The Counterargument — Does Integration Really Cut Costs?

"Do not let hatred of a people lead you to injustice.
Be just."

Qur'an, Al-Ma'idah 5:8

Fairness requires presenting the other side's argument in its strongest form. Large companies see vertical integration not as a plot against the patient but as a solution to a real problem: the fragmentation of the U.S. health system. Their arguments deserve reflection.

The first is care coordination. In a fragmented system, one doctor may not know what another prescribed; drugs may conflict; costly tests may repeat needlessly. When one entity holds the insurance, clinic, and pharmacy data, it can — in theory — build an integrated picture of the patient, catch drug interactions early, and intervene before a condition worsens. Some companies have launched AI-driven platforms to identify patients at risk of chronic disease and steer them to preventive care before hospitalization.

The second is cost reduction through prevention. Hospitalization is very expensive, and every avoidable heart attack or diabetic complication saves thousands. Companies argue that owning the care chain lets them invest in prevention and steer patients to lower-cost settings (a clinic instead of the ER), serving patient and payer alike. In principle this is sound: coordinated, data-driven care can indeed be more efficient.

The third is economies of scale. A huge company can negotiate better prices, spread administrative costs over a wider base, and invest in technologies a small player cannot. Cordavis is one example, which CVS says was created to produce cheaper biosimilars that compete with expensive originals and lower costs for patients.

Yet these arguments, however valid, face one decisive test: the evidence. A promise of efficiency is not enough; its effects must actually appear in patients' bills. When FTC documents reveal markups of thousands of percent and systematic steering of profitable prescriptions, it is legitimate to ask: where did the promised efficiency savings go? To the patient, or to the company's net profit? Integration may create efficiency, but the absence of competition can turn that efficiency into retained profit that never reaches people.

The verse commands justice even toward those we oppose: that hatred of a party must not drive us to wrong them. We do not deny companies their right to lawful profit or innovation, nor accuse them baselessly. But justice itself requires demanding transparency and measuring their promises against evidence, not slogans. The final verdict must rest on data — which so far leans more toward the critics than the defenders.

Chapter 8: What Can Be Done? Breakup, Transparency, and Reform

"Cooperate in righteousness and piety, and do not cooperate in sin and aggression."

Qur'an, Al-Ma'idah 5:2

If the diagnosis is concentrated power, the cure revolves around redistributing it and subjecting it to oversight. Several reform paths have been proposed, varying in radicalism but sharing one goal: freeing the patient from the cage.

The first path is structural separation — the most radical proposal: barring a single entity from combining insurance, drug brokerage, and pharmacy ownership. Here the Glass-Steagall analogy returns: as banks were separated, so would healthcare's arms be. Breakup forcibly recreates competition, but it is legally and politically complex and faces enormous resistance from billion-dollar companies.

The second path is mandatory transparency. Rather than breaking up companies, PBMs would be required to disclose real pricing mechanics: what the pharmacy is actually paid, the size of rebates, where the spread goes. When the system is forced to operate in daylight, excessive margins are hard to hide. Transparency alone may not suffice, but it is a prerequisite for any other reform.

The third path is passing rebates to the patient and regulating spread pricing — requiring PBMs to pass rebates directly to the patient at the point of sale instead of retaining them somewhere in the system, and banning or restricting spread pricing that earns these companies billions. These are partial but practical reforms, quickly implementable.

The fourth path is empowering alternatives: supporting independent and community pharmacies and barring forced steering toward the parent company's pharmacies restores some market balance. When the patient has a real choice, they regain some lost bargaining power, and even partial competition curbs monopoly.

There is no single magic solution; effective reform will likely blend these paths: immediate transparency, strict regulation of conflicts of interest, and breakup where harm is shown to outweigh benefit. The verse sets the governing rule: cooperate in righteousness, not in sin. A

just health system is cooperation in righteousness par excellence; one that piles profit on the back of a helpless patient is the opposite. The responsibility is collective — legislator, regulator, doctor, and citizen must all demand that health return to being a right, not a commodity in a closed cage.

Conclusion

"As for the foam, it vanishes as scum; but what
benefits people remains on the earth."

Qur'an, Ar-Ra'd 13:17

We began with a troubling image: a patient circling inside a closed loop, every step returning money to the same pocket. We end having shown that this image is no fantasy but a documented economic structure — backed by regulatory reports, congressional testimony, and the companies' own data. Vertical integration in healthcare is real, and its effects on drug prices and patient choice are tangible.

But the fairness we committed to forbids closing the door on one side. Integration may carry genuine promises of efficiency and coordination. The problem is not the abstract idea but the absence of competition and transparency that turns potential efficiency into actual monopoly. When one party holds all the cards, good intentions alone are no guarantee; a structure that preserves balance is required.

The deeper lesson transcends healthcare. It concerns every market where decision-making concentrates in one hand until the need to please people disappears. Hence the call to learn from the Great Depression: build the barriers before the collapse, not after. Protecting the patient is not hostility to the market but a safeguard of its fairness.

As a researcher at the intersection of medicine and data, I believe the coming battle will be over health data itself: who owns it, and who benefits. The more AI can predict disease and guide treatment, the more it matters that this power serve the patient, not the share price — an ethical and regulatory challenge that will be with us for years.

In the end, health is a trust before it is a trade, and the patient is a human being before a line in a budget. However complex corporate structures grow, the Qur'anic balance governs: what benefits people remains, and foam vanishes. We ask God to grant us a system that benefits people and endures, and to guide those who run it toward justice and good conduct.

And God knows best.

نبذة عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع باحثٌ في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة. يعمل في تقاطع علوم البيانات والطب والجينوم، ويهتم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة في البحث الطبي والتعليم. وهو مؤلفٌ غزير الإنتاج لعشرات الكتب ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) في مجالات تشمل الدراسات القرآنية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، واليمن والجغرافيا السياسية، وأدلة المهاجرين. كما يدير برنامج «LLM4Yemen» التعليمي الموجه لطلاب اليمن في مجال الذكاء الاصطناعي.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a is a researcher in computational biology and bioinformatics at the University of Michigan. Working at the intersection of data science, medicine, and genomics, he focuses on applications of artificial intelligence and large language models in medical research and education. A prolific author, he has written dozens of bilingual (Arabic-English) books spanning Qur'anic studies, artificial intelligence, health, Yemen and geopolitics, and immigrant guides. He also directs LLM4Yemen, an AI-skills education program for Yemeni students.

مؤلفات المؤلف

- المريض الأسير: التكامل الرأسي والتركّز الاحتكاري في منظومة الرعاية الصحية الأمريكية (2026)
- نهاية الكون في القرآن الكريم – تحليل علمي شامل (2026)
- تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي (2026)
- كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (2026)
- تصنيف الآيات في القرآن الكريم (2026)
- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (2026)
- دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (2026)
- وادي السيليكون (2026)
- أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا (2026)
- الزواج الناجح (2026)
- فن التربية (2026)
- الكليو براكتيك (2026)
- دليل اللاجئ الجديد إلى أوتاوا (2026)

عن الكتاب

شركة واحدة تملك تأمينك الصحي، والعيادة التي تراجعها، والصيدلية التي تصرف دواءك، بل والوسيط الذي يحدد سعره. يفكّك هذا الكتاب «الاستراتيجية الأسيرة» التي تحاصر المريض داخل منظومة مغلقة، مستنداً إلى وثائق لجنة التجارة الفيدرالية وشهادات الكونغرس، ويعرضُ الحجة ونقيضها: هل يخفّض التكامل الرأسي الكلفة فعلاً، أم يحوّل المرض إلى ربح؟

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع، باحث في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة ميشيغان، ومؤلف لعشرات الكتب ثنائية اللغة في الطب والتقنية والذكاء الاصطناعي والدراسات القرآنية.

ISBN